

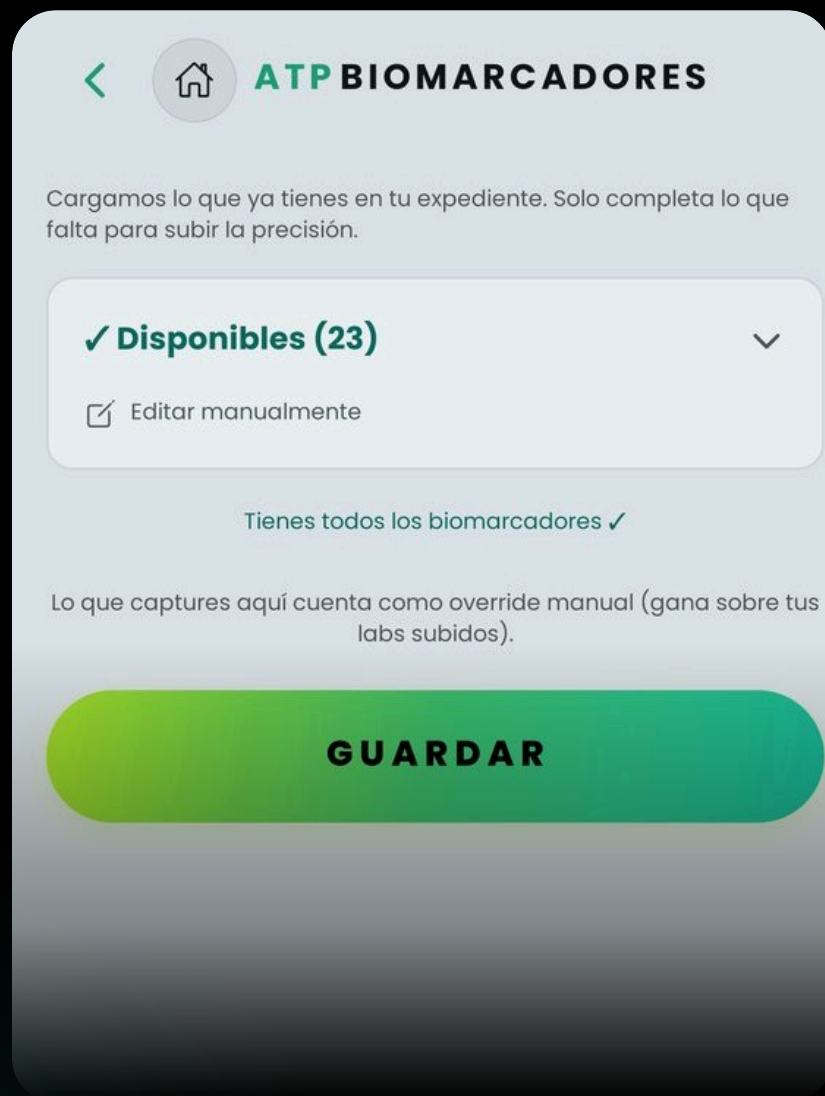
PROPUESTA, NO PRODUCTO

Lo que se puede construir si el municipio entra.

Todo lo que se enseñó antes ya funciona y se puede abrir hoy mismo en un teléfono. Lo de este documento todavía no existe, y por eso va aparte.

Nada de lo que sigue está prometido. Está
propuesto, y se construye solo si hay con quién.





PROPUESTA

Que el laboratorio local mande el resultado directo.

Hoy	La persona recibe su PDF, lo sube a la app y el modelo lo lee y lo acomoda solo. Funciona, pero depende de que la persona lo suba.
Lo que falta	Un convenio con laboratorios de la zona para que el resultado entre solo al expediente de quien se lo hizo, el mismo día, sin que nadie suba nada.
Qué se necesita	Que el municipio abra la conversación con los laboratorios con los que ya trabaja, y una integración técnica de nuestro lado.



PROPUESTA

Que el expediente llegue antes que el paciente.

Hoy

Cualquier persona genera un PDF con sus mediciones de los últimos treinta, noventa o ciento ochenta días y se lo lleva a su consulta. Números y fechas, sin interpretación.

Lo que falta

Que una unidad de salud del estado pueda consultar ese mismo expediente con el número de usuario, en el momento en que la persona llega, si la persona lo autoriza.

Qué se necesita

Un acuerdo con el sistema de salud estatal, un consentimiento explícito por persona, y un canal de consulta que nunca deje escribir del otro lado.



PROPUESTA

Que el municipio arme el catálogo de su población.

Hoy	Cada persona instala, quita y acomoda sus funciones, y puede armar la app con dos preguntas. Esa configuración es individual.
Lo que falta	Una consola donde el municipio defina un catálogo distinto por grupo: qué funciones ve el personal de campo, qué ve un programa de adultos mayores, qué ve un grupo de mujeres.
Qué se necesita	Definir los grupos con el municipio y construir la consola. Hoy eso se haría del lado nuestro, no desde una pantalla del municipio.

CÓMO SE CONSTRUYE

Tres etapas, y ninguna empieza sin que la anterior haya funcionado.

Primero	Un grupo acotado usa lo que ya existe durante 90 días. Se mide al inicio y al final. Si no se mueve, aquí se acaba.
Después	Con el grupo funcionando, se abre la conversación con laboratorios de la zona y se arma el catálogo por grupo.
Al final	La conexión con el sistema de salud estatal, que es la pieza más grande y la que más tiempo lleva.

Ningún dato de salud identificable sale hacia el municipio ni hacia terceros, en ninguna de las tres etapas.